

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SIPS · STRUCTURED INTERVIEW FOR PRODROMAL SYNDROMES

Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos – Sistema estandarizado internacional para la identificación operativa de Estados Mentales de Alto Riesgo (EMAR / CHR)

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS / PRIME Clinic)
Nombre en español	Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos
Sigla oficial	SIPS
Autores originales	Thomas H. McGlashan, Tandy J. Miller, Scott W. Woods, Barbara C. Walsh et al. (2001, 2010)
Adaptación hispanohablante	Grupo de Investigación en Estados de Alto Riesgo (CIBERSAM / Celso Arango, Julio Bobes et al.)
Año de publicación original	2001 (versión SIPS 5.0 y 5.6 consolidada en 2010)
Constructo primario	Identificación de estados prodrómicos de psicosis, criterios de ultra-alto riesgo (UHR/CHR) y conversión psicótica
Formato de administración	Entrevista clínica semiestructurada administrada por profesional de la salud mental
Población diana	Adolescentes y adultos jóvenes (12 a 30 años) con cambios incipientes en pensamiento o percepción
Tiempo de aplicación	45 a 75 minutos (entrevista diagnóstica exhaustiva)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto académico (PRIME Clinic, Yale University / CIBERSAM)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Structured Interview for Prodromal Syndromes** (SIPS) fue creada por el equipo de la PRIME Clinic (**P**revention through **R**isk **I**dentification, **M**anagement, and **E**ducation) de la Universidad de Yale liderado por Thomas H. McGlashan para transformar el diagnóstico precoz de la psicosis. Frente a la noción retrospectiva tradicional del pródromo, la SIPS propuso un marco prospectivo basado en los **Estados Mentales de Alto Riesgo (Clinical High Risk - CHR / At-Risk Mental State - ARMS)**, permitiendo identificar a jóvenes con alta probabilidad de desarrollar un primer episodio psicótico franco en los 12 a 24 meses posteriores.

El marco diagnóstico de la SIPS articula tres componentes interdependientes: 1) la Escala de Síntomas Prodrómicos (**Scale of Prodromal Symptoms - SOPS**), que cuantifica 19 síntomas en cuatro dimensiones (positivos, negativos, desorganización y generales); 2) los criterios diagnósticos operativos de los tres síndromes de alto riesgo (Síndrome de Síntomas Psicóticos Positivos Atenuados - APSS; Síndrome Psicótico Intermitente Breve - BIPS; y Síndrome de Deterioro Genético y Funcional - GRD); y 3) los criterios de **Presencia de Síntomas Psicóticos (POPS)**, que definen con rigor el momento exacto de transición a psicosis abierta. Su introducción revolucionó las unidades de intervención temprana en psicosis en todo el mundo.

3. Criterios Diagnósticos Operativos y Composición de Síndromes

Síndrome Clínico SIPS	Criterio Operativo SOPS	Fenomenología y Requisitos Cronológicos
1. Síntomas Psicóticos Positivos Atenuados (APSS)	Puntuación de 3, 4 o 5 en ≥ 1 ítem positivo (P1 a P5)	Presencia de suspicacia, ideas delirantes atenuadas o anomalías perceptivas al menos 1 vez por semana en el último mes; juicio de realidad preservado.
2. Síntomas Psicóticos Intermitentes Breves (BIPS)	Puntuación de 6 en ≥ 1 ítem positivo (P1 a P5)	Síntomas psicóticos francos con pérdida de juicio de realidad pero de duración ultra-breve (< 1 hora al día y resolución espontánea < 1 semana).
3. Deterioro Genético y de Rasgo (GRD)	Familiar 1.er grado con psicosis o TP Esquizotípico	Caída de $\geq 30\%$ en la Escala de Funcionamiento Global (GAF) en el último año mantenida al menos 1 mes, sumada a la vulnerabilidad genética.
Presencia de Síntomas Psicóticos (POPS - Transición)	Puntuación de 6 sostenida en P1 a P5	Criterio de conversión a psicosis declarada: Síntoma positivo en nivel 6 presente ≥ 1 hora diaria durante al menos 4 días por semana durante 1 mes.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Concordancia diagnóstica (Kappa)	Kappa = 0.82 – 0.94	Excelente fiabilidad interevaluador entre clínicos formados en programas de intervención temprana de CIBERSAM.
Consistencia interna SOPS	Alpha = 0.81 – 0.88	Buena coherencia interna para las dimensiones sintomáticas evaluadas durante la entrevista.
Tasa de conversión a psicosis	15% a 25% a 12 meses; 25% a 35% a 24 meses	Elevada validez predictiva para predecir la transición a esquizofrenia o trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos.
Sensibilidad predictiva	Sensibilidad > 80%	Permite capturar a la inmensa mayoría de individuos jóvenes que transicionan hacia psicosis.
Especificidad pronóstica	Especificidad > 75%	Diferencia eficazmente los síntomas transitorios del neurodesarrollo o crisis afectivas de verdaderos estados prodrómicos.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación dimensional de los síntomas SOPS (0 a 6):**
 - 0 = **Ausente**; 1 = **Dudoso**; 2 = **Leve**; 3 = **Moderado**; 4 = **Moderadamente severo**; 5 = **Severo pero no psicótico** (juicio de realidad oscilante); 6 = **Severo y psicótico** (convicción fija o alucinaciones continuas).
- **Regla de Asignación Diagnóstica Sindrómica:**
 - Se diagnostica **APSS** si al menos uno de los ítems P1 a P5 puntúa entre 3 y 5, ha comenzado o empeorado en el último año y se presenta ≥ 1 vez por semana durante el último mes.
 - Se diagnostica **BIPS** si al menos un ítem P1 a P5 alcanza nivel 6 durante al menos varios minutos pero menos de 1 hora continua.
 - Se diagnostica **GRD** si existe antecedente familiar de primer grado con trastorno psicótico más caída $\geq 30\%$ en la escala GAF.
- **Identificación de Transición (POPS):** Un ítem positivo con puntuación de 6 con duración e impacto discapacitante marca el final del pródromo y el debut del **Primer Episodio Psicótico**.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Resultado SIPS	Estado Clínico	Significación Psicopatológica y Vía Asistencial
Sin criterios de síndrome prodrómico	No Cumple Criterios CHR	Síntomas no psicóticos o explicados por neurosis, estrés o consumo. Manejo en salud mental ordinaria.
Cumple criterios APSS, BIPS o GRD	Estado Mental de Alto Riesgo (CHR / EMAR)	Punto de corte diagnóstico. Alto riesgo biológico de transición psicótica. Inclusión en Programa de Intervención Temprana.
Cumple criterios POPS (Puntuación 6 sostenida)	Primer Episodio Psicótico Franco (PEP)	Transición psicótica confirmada. Inicio de abordaje farmacológico con antipsicóticos a dosis bajas y manejo hospitalario/ambulatorio intensivo.

REGLA CRÍTICA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (MCGLASHAN ET AL., 2010): En pacientes que cumplen criterios de **APSS o GRD**, las guías internacionales (EPA, NICE) desaconsejan el uso preventivo sistemático de antipsicóticos; la intervención de primera línea debe ser **TCC adaptada para psicosis, ácidos grasos omega-3 y monitorización estrecha**.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Detección de señales de alerta en atención primaria o educación:

- Derivar a la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil o adultos jóvenes ante caída brusca del rendimiento académico, perplejidad, aislamiento social no explicado o sospechas de autorreferencialidad.

Paso 2: Aplicación de la entrevista semiestructurada SIPS:

- Administrar la SIPS por profesional acreditado. Explorar juicio de realidad con la pregunta clave: “¿Se ha preguntado si esto podría ser una mala pasada que le juega su propia mente?”.

Paso 3: Vía terapéutica recomendada para pacientes CHR/EMAR:

- Intervención Psicológica:** Terapia Cognitivo-Conductual para pródromos (reestructuración de sesgos cognitivos de conclusión precipitada / jumping to conclusions).
- Soporte Familiar y Social:** Psicoeducación libre de estigma a los padres, reducción del estrés ambiental y soporte vocacional.
- Tratamiento Biológico:** Suplementación con Omega-3 (1.2 g/día de EPA/DHA) y tratamiento farmacológico sintomático de la ansiedad/depresión con ISRS. Reservar antipsicóticos únicamente si se produce transición a POPS (criterio 6).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 17 años, estudiante de 2.º de Bachillerato, acude a consulta acompañado de su madre debido a que en los últimos 4 meses pasa todo el día encerrado en su habitación, ha bajado notablemente sus notas y dice sentirse observado por las luces de la calle.

Evaluación con la SIPS y Subescalas SOPS:

- Ítems Positivos:** P1 (Contenido inusual) = 4 (cree que la matrícula de ciertos coches contiene mensajes dirigidos a él, pero reconoce con duda que “podría ser una obsesión suya”); P2 (Suspiciencia) = 4 (desconfía de compañeros de clase); P3, P4, P5 = niveles 0 a 2.
- Ítems Negativos:** N1 (Aislamiento) = 4; N6 (Deterioro de la higiene) = 3.
- GAF actual = 52 (frente a GAF premórbido = 85).
- Diagnóstico según SIPS:** Cumple criterios de **Síndrome de Síntomas Psicóticos Positivos Atenuados (APSS)**.

Intervención Asistencial y Evolución: Se incluyó en el Programa de Prevención Precoz de Psicosis de Salud Mental. Se inició TCC para estados prodrómicos (16 sesiones quincenales), suplementación con ácidos grasos Omega-3 y orientación familiar para disminuir la sobrecarga emocional en el hogar. No se introdujeron neurolépticos. A los 12 meses de seguimiento longitudinal, los síntomas positivos se redujeron a nivel 1 (dudoso) y el joven retomó sus estudios con normalidad, evitándose la transición hacia psicosis franca.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE RIESGO EVOLUTIVO:

- Consumo de cannabis:** El consumo habitual de tetrahidrocannabinol (THC) en pacientes CHR triplica la velocidad de conversión hacia psicosis irreversible. Abordaje prioritario.
- Riesgo autolítico:** La vivencia de perplejidad y el colapso del mundo personal genera una tasa de desesperanza y suicidio del 10% en fases prodrómicas.
- Urgencia de conversión:** Si el síntoma positivo alcanza nivel 6 mantenido, activar de inmediato protocolo de Primer Episodio.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- Crisis de angustia y despersonalización:** Las alteraciones perceptivas en ataques de pánico son egodistónicas y no se acompañan de ideación autorreferencial.
- Trastorno Obsesivo-Compulsivo con baja conciencia:** En el TOC las ideas intrusivas generan angustia y resistencia; en la SIPS las ideas se viven como revelaciones.
- Trastornos de Personalidad del Grupo A:** Patrón estable desde la infancia sin el declive funcional abrupto (caída GAF) que caracteriza al pródromo.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

- Miller, T. J., McGlashan, T. H., Rosen, J. L., Cadenhead, K. S., Cannon, T. D., Ventura, J., ... & Woods, S. W. (2003). Prodromal psychosis: review and evaluation of the Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS). *Journal of Nervous and Mental Disease*, 191(9), 569–577. <https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000086884.28876.8b>
- McGlashan, T. H., Walsh, B. C., & Woods, S. W. (2010). *The Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes (SIPS): Version 5.0*. Yale School of Medicine.
- Fusar-Poli, P., Borgwardt, S., Bechdolf, A., Addington, J., Riecher-Rössler, A., Schultze-Lutter, F., ... & Yung, A. (2013). The psychosis high-risk state: A comprehensive state-of-the-art review. *JAMA Psychiatry*, 70(1), 107–120.
- Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.